

Stress Urinary Incontinence — Babae

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Pagtagas ng ihi sa pag-ubo, pagtawa, pagbuhat, o ehersisyo

Ang stress urinary incontinence (SUI) ay ang pagtagas ng ihi kapag may biglaang presyon sa pantog — tulad ng pag-ubo, pagbahin, pagtawa, pagbuhat, o ehersisyo. Sa mga babae, nangyayari ito kapag humina ang suporta sa ilalim ng urethra, madalas matapos manganak o sa menopause. Ito ay karaniwan at lubos na maaaring gamutin, mula sa simpleng mga ehersisyo hanggang sa isang mabilis at napaka-epektibong operasyon.

Tungkol sa Kondisyong Ito

Ang **urethra** (ang tubo na dinadaan ng ihi) ay karaniwang nananatiling sarado kapag umubo o nagsisikap, dahil sa suporta ng pelvic floor at mga nakapaligid na tisyu. Kapag humina ang suportang ito, ang biglaang pagtaas ng presyon sa tiyan ay nagtatulak ng ihi palabas. Ang palatandaan ay **pagtagas kapag may aktibidad** — hindi dahil sa biglaang pangangailangan (ito ay overactive bladder; ang pagkakaroon ng dalawa ay tinatawag na **mixed** incontinence).

Mga Sanhi

- **Pagbubuntis at panganganak** (pangunahing sanhi)
- **Menopause** at pagtanda
- Matagalang pag-ubo, konstipasyon, o mabigat na pagbuhat
- Labis na timbang ng katawan at nakaraang operasyon sa pelvis

MGA TERMINO

Stress incontinence

Pagtagas ng ihi kapag may presyon — pag-ubo, pagbuhat, ehersisyo.

Urethra

Ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan.

Pelvic floor

Ang mga kalamnan na sumusuporta sa pantog at urethra.

Kegels

Mga ehersisyo ng pelvic floor para palakasin ang suporta.

Mixed incontinence

Pagkakaroon ng stress leaks at urge leaks nang sabay.

Pessary / insert

Isang maliit na suporta na inilalagay sa puki (vagina) para bawasan ang pagtagas.

Urethral bulking

Isang inyeksyon sa opisina na tumutulong sa pagsara ng urethra.

Mid-urethral sling

Isang maliit na mesh support na inilalagay sa ilalim ng urethra sa operasyon.

KAILANGAN KO BA NG OPERASYON? Hindi kailangang. Maraming babae ang gumagaling sa pelvic floor exercises at simpleng pagbabago ng gawi, at ang iba ay gumagamit ng support device. Ang operasyon (tulad ng sling) ay napaka-epektibo kapag gusto mo ng pangmatagalang solusyon — ngunit ikaw ang magpapasya, at maaari kang magsimula sa mas simpleng hakbang.

Paano Ito Nasusuri

- Usapan tungkol sa kailan ka nagtatago, at pisikal na pagsusuri (minsan ay cough test)
- Isang **pagsusuri ng ihi** para ibukod ang impeksiyon, at tsek kung gaano kahusay ang pag-ihing
- Minan ay bladder-function testing (urodynamics) bago ang operasyon

Paano Ito Ginagamot (Hakbang-hakbang)

- 1 **Pelvic floor exercises** (Kegels) at physical therapy, pagbaba ng timbang, at paggamot ng ubo o konstipasyon.
- 2 **Support devices** — isang vaginal pessary o over-the-counter insert.
- 3 **Urethral bulking** — isang mabilis na inyeksyon sa opisina na tumutulong sa pagsara ng urethra.
- 4 **Operasyon** — isang **mid-urethral sling** (o autologous fascial sling) para sa pangmatagalang pagwawasto. Ang bawat opsyon ay may sariling handout.

Pamumuhay Dito

- Matutong **kumipit bago umubo, bumahin, o magbuhat** ("ang knack").
- Mag-pelvic floor exercises araw-araw — maaaring tumagal ng 6–12 linggo bago makita ang pagbabago.
- Gamutin ang konstipasyon at matagalang ubo, na nagdaragdag ng presyon.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Pangangati, biglaang pangangailangan, o **dugo sa ihi** (posibleng impeksiyon)
- Pagtagas na may **matinding pagnanais** din — maaaring naiiba ang paggamot
- Pakiramdam na hindi kumpleto ang pag-ihing

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang SUI sa babae ay pagtagas ng ihi kapag may presyon dahil sa humina na suporta sa ilalim ng urethra — karaniwan at lubos na maaaring gamutin.
2. Ang mga opsyon ay mula sa pelvic floor exercises at support device, hanggang sa bulking injection, at sling para sa pangmatagalang solusyon.
3. Ang mga ehersisyo ay nangangailangan ng ilang linggo; kumipit bago umubo o magbuhat. Ang operasyon ay pagpipilian, hindi obligasyon.